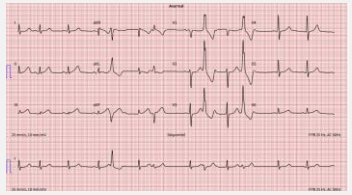
FICHE D'ENSEIGNEMENTS SUAP 2023-3 : douleur thoracique + perte de connaissance = DSA !

SITUATION OPÉRATIONNELLE

25/10/2023

- Un VSAV est sonné pour une F 59 avec demande d'ECG pour douleur thoracique.
- Lors du contact, la douleur est retro sternale avec irradiation dans le membre supérieur gauche et la mâchoire, avec sueurs. Les constantes sont normales. La femme perd connaissance pendant le contact et l'OCM demande un second ECG et en parle au médecin. Devant la PC et des extra systoles sur le 1er ECG, le médecin envoie une équipe médicale .
- Le CA précise qu'elle est en PLS, les électrodes ECG toujours en place.
- Le médecin lit le second ECG qui est une fibrillation ventriculaire et fait rappeler le VSAV pour faire masser et défibriller. On entend un équipier appeler la victime toujours inconsciente sans RCP.
- La victime est choquée 10 minutes après la PC.
- Le tracé DSA confirme 10 minutes de FV non massée.



1er ECG



2ème ECG



Tracé DSA
CEE puis MCE

PROBLÉMATIQUE

- L'ACR devant les secours donne l'opportunité d'une action de sauvegarde immédiate minimisant les effets de l'hypoxie cérébrale et permettant la délivrance d'un CEE potentiellement efficace avec réveil de la victime.
- L'action des secours doit être immédiate et efficace. C'est pourquoi une CAT optimisée est enseignée et dorénavant décrite dans le BSP 200.2.
- Sa mise en œuvre évite la non reconnaissance de l'ACR.

POINTS D'ATTENTION

- Dès l'inconscience, le CA ne passe pas en mode DSA (conscience de situation erronée): non application de la procédure enseignée au PECCH , en FMA CA, ayant déjà fait l'objet d'une FE, mais non parfaitement explicite dans le BSP 200.2 au moment de l'intervention.
- Les électrodes permettent de voir une activité électrique sur l'écran alors que la victime est en ACR. (biais cognitif)
- La CM donne une consigne erronée: refaire un ECG (conscience de situation erronée)
- Doute sur la surveillance de la personne inconsciente : pouls carotidien?

BONNES PRATIQUES

- Le médecin lit le second ECG , ce qui permet de rattraper l'erreur du CA et de faire masser et défibriller la victime (barrière d'atténuation)

CE QU'IL FAUT RETENIR

- **Dans le cadre d'une douleur thoracique ou de la réalisation d'un ECG, toute PC devant les secours impose sans délai une analyse DSA sans bilan primaire** car la probabilité d'une FV est très élevée. MAJ BSP 200.2 chap. 7.2. C'est une action de sauvegarde.
- **Il est interdit de poser un 4 brins et/ou de se fier à l'activité ECG de l'écran du DGT7 chez une personne inconsciente.**
- Lors du bilan primaire en arrivant auprès d'une personne inconsciente (qui respire), la recherche du pouls carotidien est toujours réalisée car lors d'un ACR, il persiste souvent des mouvements respiratoires au début. **Le doute sur la perception du pouls doit faire débuter immédiatement une RCP.**